Серийный номер: 142522
Модель: MAGNETOM Aera

Описание исследования
Дата проведения исследования: 16.10.2026 09:00
Цель исследования: состояние панкреатобилиарной системы? холедохолитиаз? у пациента с диспепсией ЖКБ, холецистэктомия в анамнезе

Описание результатов
На серии МР-томограмм органов брюшной полости, выполненных в стандартных проекциях (Т1, Т2ВИ, fatsat, vibe, ДВИ) и МРХПГ – печень в размерах не увеличена, ККР правой доли - 134мм. Левая доля 73мм. Контуры печени четкие и ровные, структура однородная. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Воротная вена 12мм.
Желчный пузырь удален. Культя пузырного протока длиной 16мм, шириной до 2-3мм. Холедох до 6,5мм, без дефектов наполнения.
Поджелудочная железа размерами: головка 29мм, тело 20мм, хвост 17мм. Вирсунгов проток визуализируется на всем протяжении, шириной до 1мм. Контуры железы четкие, дольчатость сохранена, структура диффузно неоднородная за счет наличия участков жировой дегенерации. Парапанкреатическая клетчатка не изменена.
На ДВИ участков измененного МР-сигнала с признаками рестрикции диффузии не выявлено.
Селезенка обычной формы и расположения, однородной структуры, размерами до 116х70х46мм (индекс 373).
Свободной жидкости и гиперплазированных лимфатических узлов в зоне исследования не визуализируется.

Заключение
Состояние после ранее перенесенной холецистэктомии. Диффузные изменения поджелудочной железы.

Заведующий отделением /_____ / КАРЕЛЬСКАЯ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская многопрофильная больница № 2»,
Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 5, тел.: 338-48-88
E-mail: b2@zdrav.spb.ru; b2@zdrav.gugov.spb.ru

КУЗЬМИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ , № МК 107574-26-С
12.05.1963 , муж

23.10.2026 11:17 ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Описание
Пищевод проходим, в шейном отделе пределяется очаг желудочной гетеротопии до 0,5см. Слизистая оболочка пищевода рыхлая,розовая, стенки эластичные, вены не расширены. Кардиальный жом смыкается не плотно на 40см от резцов , Z-линия на 1,0 см выше уровня кардии. Наблюдается заброс желчи из желудка в просвет пищевода.
Желудок обычной формы, в просвете пенистая желчь в большом количестве . Слизистая оболочка тела желудка отечная, гиперемированная. Складки эластичные, хорошо расправляются воздухом. При осмотре на инверсии угол Гиса сглажен, кардиальный жом смыкается не плотно. Перистальтика хорошо прослеживается. Слизистая оболочка антрального отдела желудка отечная, гиперемированная. Привратник смыкается не плотно, наблюдается рефлюкс желчи.
Луковица ДПК обычной формы, слизистая оболочка темно-розовая, рыхлая , бархатистая.
В постбульбарном отделе слизистая оболочка темно-розовая,рыхлая,бархатистая , в просвете пенистая желчь в большом количестве . Зона БДС визуально не изменена.
;

Заключение
Inlet patch шейного отдела пищевода. Рефлюкс-эзофагит. Эндоскопические признаки грыжи ПОД.Катаральный гастродуоденит. Дуодено-гастральный рефлюкс. ;

Врач-эндоскопист /_____ / ВЕРЕНЦОВА ТАТЬЯНА ФЕЛИКСОВНА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская многопрофильная больница № 2»,
Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 5, тел.: 338-48-88
E-mail: b2@zdrav.spb.ru; b2@zdrav.gugov.spb.ru

КУЗЬМИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ , № МК 107574-26-С
12.05.1963 , муж
26.10.2026 08:05 ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Дата отмены: 26.10.2026 08:05; Причина отмены: выполнено ранее.

ЛЕВЧЕНКО Е.И. / 26.10.2026 08:05

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская многопрофильная больница № 2»,
Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 5, тел.: 338-48-88
E-mail: b2@zdrav.spb.ru; b2@zdrav.gugov.spb.ru

КУЗЬМИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ , № МК 107574-26-С
12.05.1963 , муж
26.10.2026 11:52 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ВНУТРИВЕННЫМ КОНТРАСТИРОВАНИЕМ

Информация об оборудовании:
Название устройства: Томограф магнитно-резонансный MAGNETOM Aera
Инвентарный номер: 1378420
Серийный номер: 142522
Модель: MAGNETOM Aera

Описание исследования
Дата проведения исследования: 26.10.2026 14:08
Цель исследования: рецидив Шванномы?
Описание результатов
Выполнена серия МР-томограмм головного мозга (FLAIR, T2ВИ, T1ВИ, DWI), в том числе после внутривенного контрастного усиления (Омнискан).
В анамнезе удаление шванномы преддверно-улиткового нерва в области левого мостомозжечкового угла от 2013 г. с частичной резекцией лицевого нерва; радиохирургическое лечение от 2017 г.; повторное микрохирургическое удаление опухоли от 2024 г. (рецидив). По данным МРТ от 25.06.2026 описан интракраниальный участок накопления контрастного вещества без динамики по сравнению с исследованием от 2025 г. Предыдущие исследования на момент описания не представ-лены.
Видимые отделы спинного мозга на уровне С1–С2 утолщены. В правой половине спинного мозга определяется участок изменённого МР-сигнала с ограничением диффузии на DWI, характерного для ишемии, размерами около 33×12 мм в сагиттальной плоскости.
Желудочковая система расширена. Боковые желудочки асимметричны, индекс Эванса 0,32. III желудочек шириной 13 мм. Перивентрикулярно определяются зоны глиоза. Цистерны основания мозга расширены. Мостомозжечковая цистерна и IV желудочек расширены, IV желудочек до 37×31 мм. Наружные субарахноидальные пространства не расширены, хорошо дифференцируются над